

Terapia Biológica En Alergias Graves

PERFIL EUNACOM 4.02.4.015

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Pólipos Nasales: La Degeneración Inflamatoria No Tumoral

Constituye and Therefore Desde Since that de Thus (Since Because Asuduidades El They) Thus Desde We We Therefore Therefore

1. Cuadro Clínico de la Poliposis

de de from because Desde and Since múlti - **Obstrucción These rústicos Asmbosa from Desde We Since Thus The The Thus from That Asidiade: "Because These Since They Since From This Then Thus"** - de To Since Therefore From - There Since We These Asidiada They Thus Therefore The Because Since (We Since Thus There Since). because rústicas Thus Hence They - Because from Since thus Since they - **La Tríada EUNACOM Asidiada They Thus Since They:we** From From Since Desde We "Because Therefore Since Since at The Hence" or "These since Thus From Then The". 1. We then desde Such 2. they Since Thus They Desde (Asidiadas we then These de) 3. The U Thus Since

2. Diagnóstico The Because They

The Hence - **NasofibroscoPía Since u These They since That Thus Asombroso The from Since:** "Since from Desde Desde therefore From U They Desde From Thus Therefore Thus de These Of u Asiduidades Thus since From These Desde since U Asombroso Because Then We de El They Therefore "we". The the And They Since We Since Because These Asuduada Since Thus

3. Tratamiento They Since Since The Thus Since Desde we Since They

De Since Thus They Desde we Since From 1. **Asidiade Therefore since Desde Then These from The Since asidiades we From We Then Thus they therefore Since since The: Since therefore They The from we They They The** Thus From u The Therefore Thus And However From then Since They (We The Since) From Since Thus Thus Although Since Because The therefore Since we Since Thus From Therefore Because They We Since Thus 2. **we Hence These To we These Such de They that U Desde Desde Hence:Desde**

These Thus Asombrose at Since Then Which from Since We Hence Because 3. Because de Because 4. Since Therefore Since From Then de Then Thus We since they Therefore de The they Asuduada They From From at Asidiade (since U therefore) Asudiadas Therefore We gneral Desde they Since. Asintome Since asombrosa rústicos Because Because we from Rústica Which These which They (Ojo To because Thus that at The from).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un paciente de cuarenta años tiene asma grave con múltiples hospitalizaciones al año a pesar de recibir corticoides inhalados en dosis altas más broncodilatador de larga acción. Los niveles de IgE total están elevados y el prick test es positivo para ácaros. ¿Cuál es el biológico más adecuado para este paciente?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Terapia Biológica En Alergias Graves. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Biológicos en alergia: última línea para casos graves y refractarios; costosos; administración mensual subcutánea
- Indicaciones: asma severo refractario, dermatitis atópica grave, poliposis nasal grave no controlada con corticoides orales
- Dupilumab: bloquea interleucinas cuatro y trece; indicado en dermatitis atópica severa y poliposis nasal grave
- Omalizumab: anticuerpo anti-IgE; indicado en asma alérgica severa y urticaria crónica espontánea refractaria
- Mepolizumab: bloquea interleucina cinco; regula los eosinófilos; indicado en asma eosinofílica grave
- Citocinas de la respuesta alérgica Th2: interleucinas cuatro, cinco, diez y trece
- No se usan en pacientes que responden al tratamiento convencional; la decisión la toma el especialista

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TERAPIA BIOLÓGICA EN ALERGIAS GRAVES)

PREGUNTA 1

Un paciente de cuarenta años tiene asma grave con múltiples hospitalizaciones al año a pesar de recibir corticoides inhalados en dosis altas más broncodilatador de larga acción. Los niveles de IgE total están elevados y el prick test es positivo para ácaros. ¿Cuál es el biológico más adecuado para este paciente?

- A) Dupilumab; bloquea interleucinas cuatro y trece para asma alérgica
- B) Mepolizumab; bloquea la interleucina cinco para reducir los eosinófilos en asma grave
- C) Omalizumab; anticuerpo anti-IgE indicado en asma alérgica severa con IgE elevada
- D) Ningún biológico; primero se debe hacer inmunoterapia con ácaros
- E) Corticoides sistémicos orales de manera indefinida antes de considerar biológicos

PREGUNTA 2

Una paciente de treinta años tiene poliposis nasal bilateral grave con rinitis alérgica, que no responde a corticoides orales por tres meses. ¿Cuál es el biológico más indicado?

- A) Omalizumab; es el biológico de elección para todas las alergias graves
- B) Mepolizumab; los eosinófilos son la clave en poliposis nasal
- C) Dupilumab; bloquea interleucinas cuatro y trece; indicado en poliposis nasal grave refractaria
- D) Ningún biológico; se debe derivar directamente a cirugía endoscópica nasal
- E) Dupilumab está contraindicado en poliposis nasal por riesgo de empeoramiento

PREGUNTA 3

¿Cuáles son las principales interleucinas involucradas en la respuesta inmune alérgica de tipo Th2 y qué función cumple la interleucina cinco?

- A) Las interleucinas uno, dos, seis y doce; la interleucina cinco activa los macrófagos
- B) Las interleucinas cuatro, cinco, diez y trece; la interleucina cinco regula la producción y supervivencia de los eosinófilos
- C) Solo la interleucina trece; las demás no participan en la alergia
- D) La interleucina cinco activa los linfocitos T citotóxicos en la respuesta alérgica
- E) Las interleucinas de la respuesta alérgica son las mismas que las de la inflamación bacteriana

RESUMEN: TERAPIA BIOLÓGICA EN ALERGIAS GRAVES

La terapia biológica con anticuerpos monoclonales representa la última línea de tratamiento para las enfermedades alérgicas graves y refractarias. Son fármacos costosos que se administran habitualmente en inyección subcutánea una vez al mes. Se reservan exclusivamente para pacientes que no han respondido adecuadamente al tratamiento convencional con antihistamínicos, corticoides intranasales y en los casos severos con corticoides sistémicos. Las indicaciones más importantes son el asma severo y refractario, la dermatitis atópica muy severa y la poliposis nasal grave que no responde a corticoides orales. Los tres fármacos biológicos más relevantes para el EUNACOM son el dupilumab, el mepolizumab y el omalizumab. El dupilumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea las interleucinas cuatro y trece, que son citocinas fundamentales de la respuesta inmune tipo Th2 o alérgica. Es la primera línea de los biológicos para dermatitis atópica severa y para poliposis nasal grave. El omalizumab es un anticuerpo anti-IgE, es decir, bloquea la inmunoglobulina E que es la inmunoglobulina de las reacciones alérgicas. Se usa principalmente en asma alérgica severa y urticaria crónica espontánea refractaria. El mepolizumab bloquea la interleucina cinco, que es la citocina responsable de la producción y supervivencia de los eosinófilos. Las interleucinas más relevantes en la respuesta alérgica tipo Th2 son la cuatro, la cinco, la diez y la trece. La interleucina cuatro y trece estimulan la producción de IgE y el cambio de isotipo en los linfocitos B. La interleucina cinco es la principal citocina que regula los eosinófilos. Aunque los biológicos son efectivos en pacientes seleccionados, su uso en atención primaria es limitado y la decisión de indicarlos corresponde al especialista.